

Gestion des vaccins et consommables — Licence 2

Diapositive 1

YAO Aya Philomène Epouse KONAN

Infirmière Spécialiste/Inspecteur de soins infirmiers/Enseignante à l'INFAS d'Abidjan

Contact téléphonique :

0757230065/0101568989

email :

ayaphilo2013@gmail.com

Diapositive 2

GESTION DES VACCINS ET CONSOMMABLES AU NIVEAU DES CENTRES VACCINATEURS

2023-2024, Semestre 5

Cellule pédagogique de Santé Publique

Abidjan, le 02/07/2024

Diapositive 3

OBJECTIFS DU COURS

Diapositive 4

Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant Infirmier (ère), Sage-Femme/Maïeuticien de la Licence 2 de gérer de façon efficace les vaccins et consommables au niveau d'un centre de vaccination

Diapositive 5

Objectifs spécifiques

(1/3)

A la fin du cours, l'étudiant (e) doit être capable de:

1.

Définir quelques concepts utilisés dans la vaccination

2.

Expliquer les différents paramètres utilisés pour l'estimation des besoins en vaccins et consommables

3.

Citer les facteurs liés aux pertes de vaccins

Diapositive 6

Objectifs spécifiques

(2/3)

A la fin du cours, l'étudiant (e) doit être capable de:

4.

Enumérer les étapes de l'estimation des besoins en vaccins et consommables à partir de la méthode de la population cible

5.

Commander les vaccins et consommables

6.

Réceptionner les vaccins et les consommables

Diapositive 7

Objectifs spécifiques

(3/3)

A la fin du cours, l'étudiant (e) doit être capable de:

7.

Ranger les vaccins et solvants dans un réfrigérateur vertical et horizontal

8.

Contrôler la qualité des vaccins dans les lieux de stockage et aux postes de stratégie avancée

9.

Enumérer les précautions à prendre pour sortir les vaccins pour la vaccination

Diapositive 8

Plan de la présentation

(1/2)

Introduction

I. Définition des concepts

II. Paramètres pour l'estimation des besoins en vaccins et en consommables

III. Facteurs liés aux pertes de vaccins

IV. Étapes de la commande des vaccins et des consommables

Diapositive 9

Plan de la présentation

(2/2)

V. Commande de vaccins

VI. Réception des vaccins et consommables

VII. Rangement des vaccins et diluants

VIII. Précautions à prendre pour la sortie de vaccins

IX. Abandons vaccinaux

X. Couverture Vaccinale (CV)

Diapositive 10

Introduction (1/2)

Evaluation des activités

des centres de vaccination a permis de constater:

une faiblesse dans la gestion des vaccins sur le terrain
engendrant

une perte en vaccins très élevée

(destruction massive suite à la péremption, mauvais usage, PCV virée ...)

Diapositive 11

Introduction (2/2)

Compte tenu du

coût de plus en plus élevé des vaccins

pour les pays:

la

bonne gestion des vaccins

par les acteurs du système de santé devient

une

nécessité absolue

Diapositive 12

Définition des concepts

(1/8)

Occasions manquées

C'est une cible qui vient au centre pour une cause

telle que

la vaccination

et qui sort du centre sans être vacciné alors qu'il l'aurait dû l'être

Diapositive 13

Définition des concepts

(2/8)

Populations non atteintes

ou

hors de portée

Ce sont les

populations

qui,

bien qu'ayant accès aux services de vaccination

ne les utilisent pas

pour

des

raisons informationnelles, culturelles, sociales

ou

financières

Diapositive 14

Définition des concepts

(3/8)

Populations inaccessibles

ou

hors d'accès

Ce sont les

populations

qui vivent :

loin des centres vaccinateurs

dans des endroits difficiles d'accès

Diapositive 15

Définition des concepts

(4/8)

Dose valide

C'est

une dose de n'importe quel antigène administrée:

à l'âge recommandé

dans l'intervalle de temps approprié

Diapositive 16

Définition des concepts

(5/8)

Dose sacrifiée

Ce sont

les

doses administrées aux populations hors cibles

pour que la vaccination ait lieu

Diapositive 17

Définition des concepts

(6/8)

Enfant correctement vacciné

C'est

l'enfant qui a

reçu le nombre de vaccins et de doses

conformément

à son âge

et

au calendrier de vaccination

Diapositive 18

Définition des concepts

(7/8)

Enfant complètement vacciné

C'est

l'enfant qui a

reçu toutes les doses des vaccins

inscrit dans le calendrier de vaccination

Diapositive 19

Définition des concepts

(8/8)

Enfant complètement et correctement vacciné

C'est

l'enfant qui a

reçu toutes les doses de vaccins requis

dans le respect du calendrier vaccinal prescrit

Diapositive 20

Paramètres pour l'estimation des besoins en vaccins et en consommables

(1/15)

Estimation des besoins en vaccin et consommables

se fait selon

trois méthodes :

Méthode selon la consommation antérieure

Méthode selon le nombre de séances de vaccination

Méthode selon la population cible:

méthode utilisée en Côte d'Ivoire

Diapositive 21

Paramètres pour l'estimation des besoins en vaccins et en consommables

(2/15)

Application de cette méthode

nécessite qu'un

certain nombre de paramètres essentiels

soient définis au préalable à savoir:

Population cible

Objectif vaccinal

Contact vaccinal

Facteur de perte

Diapositive 22

Paramètres pour l'estimation des besoins en vaccins et en consommables

(3/15)

Population cible

C'est une

sous-partie de la population totale qui bénéficie de l'activité vaccinale

En Côte d'Ivoire, les

populations cibles du PEV varient selon qu'on soit en :

- vaccination de routine

-

ou

campagne de vaccination

Diapositive 23

Paramètres pour l'estimation des besoins en vaccins et en consommables

(4/15)

Populations cibles du PEV Ivoirien

Enfants de 0 à 11 mois

Femmes enceintes

Jeunes filles de 9 ans

Diapositive 24

Paramètres pour l'estimation des besoins en vaccins et en consommables

(5/15)

Tableau n°1 : Populations cibles du PEV et population cibles supplémentaires

Population cible en routine

Pourcentage

Activité vaccinale

Enfant de 0 à 11 mois

4%

de la population totale

Routine

Femme enceinte

5%

de la population totale

Routine

Jeune fille de 9 ans

1,86%

de la population totale

Routine

Pop cible supplémentaire

Enfant de 0 à 59 mois ou 0 à 5 ans

20%

de la population totale

Campagne (JNV de VPO)

Femme en Age de Reproduction

20%

de la population totale

Campagne de Td

9 mois à 14 ans

45%

de la population totale

Campagne de RR

Diapositive 25

Paramètres pour l'estimation des besoins en vaccins et en consommables

(6/15)

Objectif vaccinal

C'est

ce que l'on cherche à atteindre pour chaque antigène
dans un programme de vaccination

ou

dans une activité vaccinale

Varie selon le type de vaccin

et

l'activité vaccinale

(vaccination de routine ou campagne de vaccination)

Doit être réaliste

et

fixé en fonction des priorités
de la lutte contre la maladie

Diapositive 26

Paramètres pour l'estimation des besoins en vaccins et en consommables

(7/15)

Tableau n°2 : Objectifs vaccinaux par antigène selon le type de vaccin appliqués en Côte d'Ivoire (DCPEV, 2022)

Antigènes

Objectifs vaccinaux

En routine

En campagne

BCG

95 %

VPO

95 %

100%

Vaccin anti Hépatite B pédiatrique

95 %

VPI

95 %

DTCHepHib (Pentavalent)

95 %

RR (Rubéole, Rougeole)

95 %

100%

Rotarix

95 %

PCV13

95 %

VAA

95 %

Td

95 %

100 %

Vaccin contre le Papilloma Virus Humain (HPV)

95 %

Vaccin Antimeningococcique A

95 %

100 %

Diapositive 27

Paramètres pour l'estimation des besoins en vaccins et en consommables

(8/15)

Contact vaccinal ou dose par cible

C'est

une dose d'un vaccin administrée à un sujet cible pour assurer sa protection

Nombre de contacts vaccinaux annuels

qu'il faut pour un sujet cible :

varie

d'un vaccin à un autre

et

se détermine

à partir du calendrier de vaccination en vigueur dans un pays

Diapositive 28

Paramètres pour l'estimation des besoins en vaccins et en consommables

(9/15)

Tableau n°3 : Contacts vaccinaux par antigène

Antigènes

Nombre de contacts

DN-Hépatite B

1

BCG

1

DTCHepB-Hib ou vaccin pentavalent

3

Rotarix

2

PCV13

3

VPO (Vaccin Polio Oral)

4

VPI (vaccin Polio Inactivé)

2

RR (Vaccin contre la rougeole et la Rubéole)

2

VAA (vaccin anti Amaril)

1

Td (Vaccin contre le tétanos et la diphtérie)

3

Vaccin Antimeningococcique A

1

Vaccin contre le Papilloma virus humain (HPV) pour jeunes filles séronégative

1

Vaccin contre le Papilloma virus humain pour jeune fille séropositive au VIH

3

Diapositive 29

Paramètres pour l'estimation des besoins en vaccins et en consommables
(10/15)

Facteur de perte (FP)

C'est

une perte en dose de vaccin due au conditionnement en flacons multidoses
se calcule à partir
du taux de perte du vaccin

Diapositive 30

Paramètres pour l'estimation des besoins en vaccins et en consommables

(11/15)

Tableau n°4 : Taux de perte par antigène

Antigènes

Taux de perte

BCG

40%

VPO

10%

Vaccin anti hépatite pédiatrique

10%

DTC-

HepB

-Hib

10%

VPI

10%

Rotarix

5%

PCV13

5%

Td

10%

RR (vaccin contre la rougeole et la rubéole)

15%

Vaccin Anti Amaril

15%

Vaccin Antimeningococcique A

15%

Vaccin contre le Papilloma virus humain (HPV)

5%

Seringues

10%

Diapositive 31

Paramètres pour l'estimation des besoins en vaccins et en consommables

(12/15)

Tableau n°5 : Facteur de perte par antigène

Antigènes

Facteur de perte

BCG

1,66

VPO

1,11

Vaccin anti hépatite pédiatrique

1.11

DTC-HepB-Hib

1,11

VPI

1,11

Rotarix

1.05

PCV13

1.05

Td

1.11

RR

1,17

Vaccin Anti Amaril

1.17

Vaccin Antimeningococcique A

1.17

Vaccin contre le Papilloma virus humain (HPV)

1.05

Seringues

1.11

Diapositive 32

Paramètres pour l'estimation des besoins en vaccins et en consommables

(13/15)

Formule du calcul du taux de perte

Doses sorties-Doses administrées

T Pertes = ----- x 100

ou

100 –

TU du vaccin

Doses sorties

Diapositive 33

Paramètres pour l'estimation des besoins en vaccins et en consommables

(14/15)

Formule du calcul du taux d'utilisation du vaccin (TU)

Nbre de doses effectivement administrées pendant
une période donnée

TU= -----X 100
Nbre de doses sorties pendant la même période

Ou

TU = 100 –

Tperte

du vaccin

Diapositive 34

Paramètres pour l'estimation des besoins en vaccins et en consommables

(15/15)

Formule du calcul du facteur de perte

100

F pertes = -----

100- T Pertes

Diapositive 35

Facteurs liés aux pertes de vaccins

(1/3)

Facteurs évitables de perte de vaccins

Mauvaise gestion des stocks entraînant

un approvisionnement excédentaire

et la

péremption des vaccins avant leur utilisation

Défaillance de la chaîne de froid exposant ainsi les

vaccins à des températures extrêmement inacceptables

(trop élevées ou trop basses)

Diapositive 36

Facteurs liés aux pertes de vaccins

(2/3)

Facteurs évitables de perte de vaccins

Administration des doses incorrectes

- Par ex :

l'administration de plus de trois gouttes de VPO au lieu de deux

Perte, détérioration, casses ou vol des vaccins

où

Ces facteurs peuvent être améliorés par une bonne gestion des vaccins

Diapositive 37

Facteurs liés aux pertes de vaccins

(3/3)

Facteurs inévitables de perte de vaccins

Application de la politique du flacon entamé
qui consiste

à

jeter

les flacons de vaccins reconstitués

6 heures après leur reconstitution

même si la température de conservation est normale

Diapositive 38

Etapas de la commande des vaccins et des consommables

(1/12)

Commande des vaccins

Estimation des besoins théoriques en vaccin

Besoin théorique annuel

Besoin annuel =

Population cible x Objectif vaccinal x Nombre de contact x Facteur de perte

Diapositive 39

Etapas de la commande des vaccins et des consommables

(2/12)

Commande des vaccins

Estimation des besoins théoriques en vaccin

Besoin théorique mensuel

P cible x Objectif vaccinal x Nbre

de contact x F perte x Période

Besoin théorique (BT) mensuel =

Diapositive 40

Etapes de la commande des vaccins et des consommables
(3/12)

Commande des vaccins

Estimation des besoins théoriques en vaccin

Stock de Sécurité en vaccin (SS)

utilisé comme

imprévu

pour permettre de

prendre en charge les populations cibles de passage

en provenance d'autres aires sanitaires ou

satisfaire les cas de rattrapage de vaccins

représente

25% du besoin théorique

Diapositive 41

Etapes de la commande des vaccins et des consommables

(4/12)

Commande des vaccins

Estimation des besoins théoriques en vaccin

Stock de Sécurité en vaccin (SS)

Besoin Théorique x 25

Stock de Sécurité (SS)=

pour les vaccins

100

Diapositive 42

Etapes de la commande des vaccins et des consommables

(5/12)

Commande des vaccins

Estimation des besoins théoriques en vaccin

Besoin Réel (BR)

- C'est l'ensemble du stock de vaccins prévu aussi bien pour les besoins théoriques que le stock de sécurité

Besoin Réel (BR) =

Besoin Théorique (BT) + Stock de Sécurité (SS)

Diapositive 43

Etapes de la commande des vaccins et des consommables

(6/12)

Commande des vaccins

Remarque

Quantité en Stock (QS)

Il est souvent possible que les
stocks commandés ne soient pas épuisés
par les populations, surtout lorsque le
taux de fréquentation de la structure
devient

faible

pendant une période donnée

Dans ce cas, il est conseillé de
faire un inventaire

en vue

d'extraire les quantités stockées des besoins réels
et

éviter les surstocks

et les

risques de péremption des vaccins

Diapositive 44

Etapes de la commande des vaccins et des consommables

(7/12)

Commande des vaccins

Estimation des besoins théoriques en vaccin

Quantité à Commander (QC)

Quantité à commander (QC) =

Besoin Réel (BR) - Quantité en Stock (QS)

Diapositive 45

Etapes de la commande des vaccins et des consommables

(8/12)

Commande des consommables

Commande des seringues autobloquantes

Commande des seringues autobloquantes ou seringue d'administration des vaccins faite selon la même démarche de commande des vaccins

Différence

se situe à

deux niveaux :

Facteur de perte des seringues :

1,11

Stock de sécurité :

10% du besoin théorique

Diapositive 46

Etapas de la commande des vaccins et des consommables

(9/12)

Commande des consommables

Commande des seringues autobloquantes

Stock de sécurité (SS)

Besoin Théorique x 10

Stock de Sécurité (SS)=

pour les consommables

100

Diapositive 47

Etapes de la commande des vaccins et des consommables

(10/12)

Commande des consommables

Commande des seringues à dilution

Pour diluer un

flacon de vaccin lyophilisé

, il faut une

seringue de dilution

Par conséquent,

il faut:

calculer le nombre de doses de vaccins

et

les convertir en flacons

dont le

nombre correspondra au nombre de seringues de dilution

Diapositive 48

Etapes de la commande des vaccins et des consommables

(11/12)

Commande des consommables

Commande des boîtes de sécurité

Nombre de boîtes de sécurité à commander

dépend

du

nombre de seringues utilisés pour la vaccination

(seringues autobloquantes + seringues de dilution)

Une

boîte de sécurité

peut

contenir en moyenne

100 seringues

Diapositive 49

Etapes de la commande des vaccins et des consommables

(12/12)

Commande des consommables

Commande des boîtes de sécurité

(Seringue de dilution +seringue d'injection)

Boîte de Sécurité (BS)=

100

Diapositive 50

Commande de vaccins

(1/3)

Après l'estimation des besoins en vaccin,
il faut passer la commande

Cela consiste à :

Faire l'

inventaire

de la

quantité de vaccin en stock

avant toute commande (fiche d'inventaire)

Remplir la fiche de commande de vaccin (à retirer auprès du CPEV) (quantité à commander pour chaque antigène et quantité en stock)

Commande des antigènes se fait sur le même bordereau de commande

Diapositive 51

Commande de vaccins

(2/3)

Précautions à prendre pour la commande de vaccins

Toute commande de vaccins doit être faite en prenant des précautions

suivantes :

S'assurer que la capacité de stockage disponible est adéquate

S'assurer que la conservation des vaccins est conforme aux normes recommandées

S'assurer que les

intrants nécessaires à la conservation

(électricité, gaz stabilisateurs, groupe électrogène) et à l'administration (diluants, seringues, BS, coton, outils de gestion...)

commandés

ou

disponibles

Diapositive 52

Commande de vaccins

(3/3)

Périodicité de commande de vaccins et consommables

Niveau

Période

Dépôt central

Chaque 6 mois

Dépôts régionaux

Chaque 3 mois

Dépôts districts

Chaque mois

Centre de santé

Chaque mois

Case de santé

Chaque semaine

Diapositive 53

Réception des vaccins et consommables

(1/2)

Dès la réception des vaccins

, il faut:

S'assurer que la quantité sur le bordereau est conforme à la quantité reçue

Vérifier les paramètres ci-dessous:

Nom de l'antigène

Numéros de lot

Statut de la PCV

Date de péremption

Diapositive 54

Réception des vaccins et consommables

(2/2)

Dès la réception des vaccins

, il faut:

Vérifier les paramètres ci-dessous:

Conditionnement

Etat des vaccins

Indicateur de monitoring de température

Remplir les fiches de stock pour chaque antigène tout en renseignant toutes les rubriques

Diapositive 55

Rangement des vaccins et diluants

(1/21)

Rangement des vaccins et diluants

survient

après leur réception

Il consiste à:

assurer aux vaccins les conditions de conservation requises

(entre +2 et +8°C)

pour

ne pas rompre la chaîne de froid

,

assurant ainsi la qualité aux vaccins

Diapositive 56

Rangement des vaccins et diluants

(2/21)

Rangement des vaccins et diluants

survient

après leur réception

Elément central

dans le rangement des vaccins

: réfrigérateur

C'est pourquoi dès la réception et après vérification nécessaire

,

il faut

immédiatement

les ranger dans les réfrigérateurs

en fonction de leur sensibilité à la lumière et de la congélation

Diapositive 57

Rangement des vaccins et diluants

(3/21)

Vaccins du PEV

sensibles à la lumière

Vaccin BCG

Vaccin contre la Rubéole,

Vaccin contre la Rougeole-Rubéole (RR)

où

Ces vaccins sont reconnaissables par

leurs flacons teintés en noir

Diapositive 58

Rangement des vaccins et diluants

(4/21)

Vaccins du PEV

sensibles à la chaleur

BCG

VAA

Penta

Td

PCV13

VPI

RR

VPO

Rotarix

Diapositive 59

Rangement des vaccins et diluants

(5/21)

Vaccins du PEV

sensibles à la chaleur

Ordre de Sensibilité

de vaccin à la chaleur

Echelle

Vaccins

Très sensibles

Moins sensibles

VPO

RR

Penta+ VAA+VPI+ PCV13

BCG

VAT/Td

Diapositive 60

Rangement des vaccins et diluants

(6/21)

Vaccins du PEV

sensibles à la congélation

BCG, VAA, RR

après reconstitution

DTChepB

Hep B pédiatrique

Hib liquide

PCV13

Rotarix

VAT/Td

VPI

Vaccin contre le Papilloma virus humain

Diapositive 61

Rangement des vaccins et diluants

(7/21)

Vaccins du PEV

sensibles à la congélation

Ordre de Sensibilité

de vaccin à la congélation

Echelle

Vaccins

Très sensibles

Moins sensibles

Hépatite B pédiatrique

Hib liquide

DTC, DTC-Hep B +PENTA, PCV13

VPI, Rotarix

VAT/Td ,Hib (lyophilisé),VAA,BCG et le diluant

Diapositive 62

Rangement des vaccins et diluants

(8/21)

Rangement des vaccins et diluants dans un réfrigérateur (VERTICAL)

Rangement de vaccins et diluants dans un réfrigérateur vertical doit obéir à certaines règles

à savoir:

Disposer les vaccins de sorte à avoir une bonne circulation de l'air

Disposer les vaccins de sorte à permettre leur identification et une lecture rapide de la date de péremption

Diapositive 63

Rangement des vaccins et diluants

(9/21)

Rangement des vaccins et diluants dans un réfrigérateur (VERTICAL)

Ranger les flacons entamés après les avoir marqués de couleur de sorte à les utiliser en premier lieu lors de la prochaine séance de vaccination selon la règle Premier à Expirer Premier à Utiliser (PEPU)

Disposer les vaccins dans le réfrigérateur en respectant les règles Premier à Périr Premier à Sortir (PPPS)

Diapositive 64

Rangement des vaccins et diluants

(10/21)

Rangement des vaccins et diluants dans un réfrigérateur (VERTICAL)

Ranger les vaccins sensibles à la chaleur dans le premier compartiment ou sur l'étagère supérieur, près du freezer (BCG, VAA, RR, etc.), et ceux sensibles à la congélation sur l'étagère du milieu, loin du compartiment congélateur (Td, vaccin contre le Papilloma virus humain, etc.)

Ranger les diluants à l'étagère du bas ou compartiment du bas

Diapositive 65

Rangement des vaccins et diluants

(11/21)

Rangement dans un réfrigérateur horizontal ou Bahut

Ranger les flacons de vaccins sensibles à la chaleur tels le vaccin contre la Rougeole-Rubéole, le VPO, le BCG, le vaccin Antiamaril au fond du réfrigérateur sur des accumulateurs de froid pour surélever les vaccins

Diapositive 66

Rangement des vaccins et diluants

(12/21)

Rangement dans un réfrigérateur horizontal ou Bahut

Ranger Les vaccins sensibles à la congélation comme la PCV13, le Rotarix, le penta, l'Hépatite B pédiatrique, Td, l'Hib, le vaccin Antimeningococcique A, le VPI, le vaccin contre le Papilloma virus humain au sommet (partie supérieure, loin du fond où ils peuvent être exposés à la congélation)

Diapositive 67

Rangement des vaccins et diluants

(13/21)

Rangement dans un réfrigérateur horizontal ou Bahut

Les diluants pour le vaccin contre le BCG, la RR la FJ se rangent également à côté des vaccins sensibles à la congélation

Diapositive 68

Rangement des vaccins et diluants

(14/21)

CAT en cas de flacons suspectés de congélation

Si un

flacon de vaccin liquide est

suspecté de congélation

, il faut :

Prendre le flacon de vaccin suspecté de congélation et un autre non congelé du même vaccin et du même fabricant

Agiter les deux flacons pendant au moins 5 mn

Laisser reposer les deux flacons pendant 15 à 20 minutes

Diapositive 69

Rangement des vaccins et diluants

(15/21)

CAT en cas de flacons suspectés de congélation

- Comparez le flacon suspect avec le flacon test

Si le vaccin congelé s'éclaircit et il n'y a pas de sédiment qui se dépose au fond du flacon, c'est qu'il est bon et il faut l'utiliser

Si le vaccin congelé devient complètement clair et une épaisse couche de sédiment se forme au fond du flacon, c'est qu'il n'est pas bon et il ne faut pas l'utiliser

Diapositive 70

Rangement des vaccins et diluants

(16/21)

Politique du flacon entamé

C'est une

technique de gestion des vaccins

Elle permet de

réduire de façon substantielle les taux de pertes

Diapositive 71

Rangement des vaccins et diluants

(17/21)

Politique du flacon entamé

Elle consiste à réutiliser un flacon de vaccin liquide ouvert et duquel l'on a prélevé une ou plusieurs doses de vaccins pour la prochaine séance de vaccination

jusqu'à 4 semaines

à condition que ce vaccin :

Ne soit pas périmé

N'ait pas été contaminé (règles d'asepsie observées lors du prélèvement des doses)

Diapositive 72

Rangement des vaccins et diluants

(18/21)

Politique du flacon entamé

N'ait pas été exposé excessivement au froid ou à la chaleur excessive

N'ait pas été immergés dans de l'eau

Ne présente aucun trouble ou précipitation

N'ait pas la PCV virée

Diapositive 73

Rangement des vaccins et diluants

(19/21)

Politique du flacon entamé

Politique du flacon entamé s'applique
uniquement

aux vaccins multidoses liquides

: VPO, Td, penta, PCV13, Rotarix, vaccin contre le Papilloma virus humaine

Diapositive 74

Rangement des vaccins et diluants

(20/21)

Politique du flacon entamé

Vaccins reconstitués

(BCG, RR, VAA et le vaccin contre la méningite)

ne sont pas inclus dans la directive de la politique du flacon entamé

,

car ils ne doivent pas être conservés

plus de 6 heures

après leur reconstitution

Diapositive 75

Rangement des vaccins et diluants

(21/21)

Politique du flacon entamé

NB : La

PFE

ne s'applique pas

aux flacons de VPI

dont la

PCV est collée sur le capuchon

Diapositive 76

Précautions à prendre pour la sortie de vaccins

(1/6)

Après rangement des vaccins,

Certaines précautions doivent être observées
pendant la sortie et le transport des vaccins
aux postes de stratégie avancée

Diapositive 77

Précautions à prendre pour la sortie de vaccins

(2/6)

Précautions pendant la sortie de vaccin du réfrigérateur

Tenir compte de la

date de péremption

du vaccin et

non de sa date de réception

Sortir en

premier les vaccins dont le carré s'est assombri

mais qui est

toujours plus clair que le cercle

Sortir en

premier les vaccins liquides utilisés et ramenés

dans le cadre de la politique du flacon entamé

Diapositive 78

Précautions à prendre pour la sortie de vaccins

(3/6)

Précautions pendant la sortie de vaccin du réfrigérateur

Eviter

d'exposer pendant longtemps les vaccins à la chaleur

et au froid selon leur sensibilité

Refermer aussitôt la portière du réfrigérateur

une fois la sortie des vaccins terminée

Diapositive 79

Précautions à prendre pour la sortie de vaccins

(4/6)

Précautions pendant le transport du vaccin

Utiliser de préférence les accumulateurs de froid non congelés

pour le transport des vaccins sensibles à la congélation (DTCHepB, Td, Hépatite B pédiatrique, le vaccin contre le Papilloma virus humain)

ou

isoler les vaccins en utilisant les sachets plastiques

dans le cas où tous les accumulateurs sont congelés

Diapositive 80

Précautions à prendre pour la sortie de vaccins

(5/6)

Précautions pendant le transport du vaccin

Utiliser les accumulateurs bien congelés pour le transport des vaccins VPO, RR, BCG, VAA ...

Eviter

, si possible,

les secousses

pour éviter de détériorer les vaccins

Diapositive 81

Précautions à prendre pour la sortie de vaccins

(6/6)

Précautions pendant le transport du vaccin

Ne

transporter les vaccins

que dans les

dispositifs adaptés et réservés à cet effet

(Glacière, porte vaccins etc.)

Ne pas mettre des sachets d'eau congelée

dans les glacières car une fois décongelés, ils pourront détruire la PCV

Diapositive 82

Abandons vaccinaux

(1/8)

Définition

L'

abandon

vaccinal

se définit comme

toute cible qui a utilisé les services de vaccination

et

qui n'a pas complété sa vaccination

Il

s'évalue

pour les

vaccins à multiples contacts

Diapositive 83

Abandons vaccinaux

(2/8)

Calcul des taux d'abandon (TA)

VPO0 – VPO3

TA (VPO) =

$$\frac{\text{-----}}{\text{VPO0}} \times 100$$

Diapositive 84

Abandons vaccinaux

(3/8)

Calcul des taux d'abandon (TA)

Penta 1 – Penta 3

TA (Penta) =

$$\frac{\text{-----}}{\text{Penta 1}} \times 100$$

Diapositive 85

Abandons vaccinaux

(4/8)

Calcul des taux d'abandon (TA)

Td 1- Td 2

TA (Td) =

$$\frac{\text{-----}}{\text{Td 1}} \times 100$$

Diapositive 86

Abandons vaccinaux

(5/8)

Calcul des taux d'abandon (TA)

Penta 1 – RR 1

Taux d'abandon Global =

----- X 100

Penta 1

Diapositive 87

Abandons vaccinaux

(6/8)

Causes possibles des abandons vaccinaux

Vaccination non réalisée au quotidien

Insuffisance de stratégies avancées

Recherche active des perdus de vue non organisée

Beaucoup d'occasions manquées de vaccination

Faible niveau de communication

Crainte d'un taux de perte élevé de vaccin (PF)

Diapositive 88

Abandons vaccinaux

(7/8)

Stratégies de réduction des abandons

Rapprochement des services de vaccination des populations (plus de centres vaccinateurs, postes avancés, stratégies avancées)

Renforcement de la communication interpersonnelle et de la mobilisation sociale autour de la vaccination

Diapositive 89

Abandons vaccinaux

(8/8)

Stratégies de réduction des abandons

Renforcement de l'identification et de la recherche des enfants non vaccinés en y associant les agents de santé communautaire

Mise à jour systématique et régulière des registres de vaccination

Approvisionnement continu en vaccins et consommables

Diapositive 90

Couverture Vaccinale (CV)

(1/7)

Couverture vaccinale

C'est la population cible ayant reçu le nombre de doses requis conformément au calendrier PEV

Diapositive 91

Couverture Vaccinale (CV)

(2/7)

Taux de couverture vaccinale globale

Proportion de la population cible ayant reçu le nombre requis de doses de chaque antigène du PEV pendant une période donnée

Diapositive 92

Couverture Vaccinale (CV)

(3/7)

Taux de couverture vaccinale globale

Formule de calcul des taux de couverture vaccinale globale

Population cible ayant reçu le nombre requis de doses de

Vaccins de chaque antigène pendant une période donnée

TCV Globale =

----- X 100

Population cible de la même période

Diapositive 93

Couverture Vaccinale (CV)

(4/7)

Taux de couverture vaccinale spécifique d'un antigène donné

Proportion de la population cible ayant reçu le nombre requis de doses de l'antigène du PEV pendant une période donnée

Diapositive 94

Couverture Vaccinale (CV)

(5/7)

Taux de couverture vaccinale spécifique d'un antigène donné

Formule de calcul des taux de couverture d'un antigène donné

Population cible ayant reçu le nombre de doses requis
de l'antigène pendant une période donnée

TCV d'un antigène =

$$\frac{\text{Population cible ayant reçu le nombre de doses requis de l'antigène pendant une période donnée}}{\text{Population cible de l'antigène pendant la même période}} \times 100$$

Diapositive 95

Couverture Vaccinale (CV)

(6/7)

Causes des faibles taux de couverture vaccinale

Occasions manquées de vaccination

Abandons vaccinaux

Populations hors de portée

Populations hors d'accès

Diapositive 96

Couverture Vaccinale (CV)

(7/7)

Actions à mener en vue d'augmenter la couverture vaccinale

Rechercher activement les enfants ayant abandonné la vaccination

Intensifier l'information et la sensibilisation sur la vaccination

Organiser régulièrement les séances de vaccination

Tenir compte des activités socioculturelles dans la planification des séances de vaccination

Diapositive 97

Exercice

Vous êtes infirmier diplômé d'Etat dans le Centre de Santé Rural (CSR) d'

Assirikro

en janvier 2024. Le médecin chef vous demande de passer la commande des vaccins BCG, Penta, VPO, HPV pour la jeune fille de 09 ans séronégative, VAA, Td, des seringues BCG, seringues à dilution pour le BCG, les seringues autobloquantes et des boîtes de sécurité, sachant que:

La population totale 2024: 60 000 habitants

L'objectif vaccinal est fixé à 95% pour 2024

Le taux de perte:

BCG: 40%, Penta: 10%, VPO: 10%, HPV: 5%, VAA: 15%, Td: 10%, Seringue: 10%

Diapositive 98

Rappel des calendriers vaccinaux PEV

(1/6)

Calendrier vaccinal de l'enfant de 0 à 11 mois

Age

Contacts

Vaccins

Maladies

Naissance

1

er

Contact

DN-Hep B, BCG, VPO 0

Hépatite Virale,

Tuberculose

Poliomyélite

6 semaines

2

ème

contact

DTC-Hép B-Hib, VPO1, PCV13-1,

Rota 1

,

VPI 1

Diphtérie, Tétanos, Coqueluche,

Hépatite virale B, Poliomyélite, Méningite à hemophilus influenzae de type B

Méningite à pneumocoques et infections respiratoires aiguës,

Diarrhées à rotavirus

10 semaines

3

ème

contact

Penta 2, VPO 2, PCV13-2,

Rota 2

14 semaines

4

ème

contact

Penta 3, VPO3, PCV13-3,

VPI 2

9 mois

5

ème

contact

RR1

, VAA,

Men A

Rougeole, Rubéole, Fièvre Jaune, méningite de type A

15 mois

6

ème

contact

RR2

Rougeole, Rubéole,

Diapositive 99

Rappel des calendriers vaccinaux PEV

(2/6)

Calendrier vaccinal de la femme enceinte

Période

Antigène à administrer

Durée de protection

A la 1

ère

CPN

1

ère

dose de Td

Pas de protection

4 semaines après le Td 1

2

ème

dose de Td

3 ans

6 mois après le Td 2

3

ème

dose de Td

5 ans

1 an après le Td 3

4

ème

dose de Td

10 ans

1 an après le Td 4

5

ème

dose de Td

Protection à vie

Diapositive 100

Rappel des calendriers vaccinaux PEV

(3/6)

Calendrier vaccinal des Jeunes filles de 9 ans

Age

Antigène à administrer

9 ans (jeune fille)

HPV (dose unique)

09 ans avec VIH positif

HPV 1 (9 ans)

HPV 2 (2 mois après la 1

ère

dose)

HPV 3 (4 mois après la 2

ème

dose)

Diapositive 101

Rappel des calendriers vaccinaux PEV

(4/6)

Calendrier de rattrapage des cibles du PEV (Enfant)

Antigène

Calendrier vaccinal

Période de rattrapage

Nombre de dose

Age d'administration

Hépatite B à la naissance

01 dose

A la naissance (24h de vie)

Jusqu'à 72 h de vie

BCG

01 dose

A la naissance

Jusqu'à 23 mois

VPO zéro

01 dose

A la naissance

Jusqu'à 2 semaines

VPO

03 doses

6 semaines (1 mois et ½)

10 semaines (2 mois et ½)

14 semaines (3 mois et ½)

Jusqu'à 23 mois

VPI

02 doses

6 semaines (1 mois et ½)

14 semaines (2 mois et ½)

Jusqu'à 23 mois

DTC-

HepB

-Hib

3 doses

6 semaines (1 mois et ½)

10 semaines (2 mois et ½)

14 semaines (3 mois et ½)

Jusqu'à 23 mois

Diapositive 102

Rappel des calendriers vaccinaux PEV

(5/6)

Calendrier de rattrapage des cibles du PEV (Enfant/Jeune fille)

Antigène

Calendrier vaccinal

Période de rattrapage

Nombre de dose

Age d'administration

Rota

02 doses

6 semaines (1 mois et ½)

10 semaines (2 mois et ½)

Jusqu'à 23 mois

PCV13

03 doses

6 semaines (1 mois et ½)

10 semaines (2 mois et ½)

14 semaines (3 mois et ½)

Jusqu'à 23 mois

Rougeole/Rubéole

02 doses

9 mois

15 mois

Jusqu'à 23 mois

Méningite A

01 dose

09 mois

Jusqu'à 23 mois

VAA

01 dose

09 mois

Jusqu'à 23 mois

HPV

(

jeune fille)

01 dose

9 ans (dose unique)

Jusqu'à 14 ans

HPV

(

jeune fille séropositive)

03 doses

9 ans

2 mois après la 1
ère
dose
4 mois après la 2
ème
dose
Jusqu'à 14 ans

Diapositive 103

Rappel des calendriers vaccinaux PEV

(6/6)

Calendrier de rattrapage des cibles du PEV (femme enceinte)

Antigène

Calendrier vaccinal

Période de rattrapage

Nombre de dose

Age d'administration

Td

05 doses

1

er

contact

1 mois après la 1

ère

dose

6 mois après la 2

ème

dose

1 an après la 3

ème

dose

1an après la 4

ème

dose

Jusqu'à 3 ans après l'accouchement

Diapositive 104

MERCI POUR VOTRE
QUALITE D'ÉCOUTE